EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92815
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 14-09-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS CAMILO SEPULVEDA CABEZAS			**RUN**	: 8.631.514-9
F.Nac	: 04-12-1958	**Edad**	: 65 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: BULI ORIENTE LA COPA SITIO 11			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	**Teléfono**	: 995045816		
Fecha Ingreso	: 2024-09-11	**Fecha Egreso**	: 14-09-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda
-Exacerbación EPOC | Enfisema severo bilateral
-ICC
-Usuario de O2 domiciliario
-HTP (PAP 72mmHg)
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente acude a SU con exacerbación de disnea y accesos de tos, además de cianosis distal, en contexto de insuficiencia respiratoria aguda de al menos dos días de evolución. Usuario de O2 domiciliario, parte de programa AVNIA, en seguimiento por BP. Hipertensión pulmonar en seguimiento por Cardiología, tratada con Sildenafil.
Ultima exacerbación EPOC en febrero 2024. Previamente en terapia profiláctica con Azitromicina 500mg vo 3 veces a la semana.

Ex físico
Piel: cambios y signos propios de la edad. Buen llenado capilar.
CP: Torax asimétrico, hipoexpansible, WOB++++ RSRSPS estertores bilaterales, disminuidos en ambas bases.
Abd: RHA, sin megalias, no impresiona doloroso.
Neurológico: Consciente, orientada en tiempo espacio y persona. Sin signos de focalización o irritación meníngea.

Durante estancia, paciente en regulares condiciones generales.
Con disnea próxima a basal, abundante expectoración. Niega mayor sintomatología.Hospitalización se prolonga parcialmente por error en uso de VMNI: generando aumento parcial de PCO2. En relación a control previo, GSA de hoy con elevación disminución significativa PCO2 (49->75mmHg->33mmHg)
En vista de condición favorable se decide alta médica.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano, hiposódico

3. Azitromicina 500mg vo lun-mie-vie
4. Trelegy 1 puff día
5. Ipratropio 4 puff c8h
6. Furosemida 40mg vo c12h
7. Enalapril 5mg vo c12h
8. Amlodipino 10mg vo dia
9. Sildenafil 50mg vo c8h
10. KNT R: Asegurar terapia ventilatoria en domicilio. Asegurar tomas y hacer prueba de saturación con VMNI en domicilio.
11. Control SU SOS
12. Seguimiento BP CAE

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO